

Acadêmico (a): _____

Fase: _____

ENAMED

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES:

1. *Esta prova possui questões objetivas de conhecimento específico.*
2. *Todas as respostas devem ser de caneta azul ou preta.*
3. *Não é permitido o uso de celulares e outros objetos eletrônicos.*
4. *Esta prova é individual. São vedados: qualquer comunicação entre os presentes.*
5. *Não é permitido durante a prova a solicitação de dúvidas ao professor.*

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

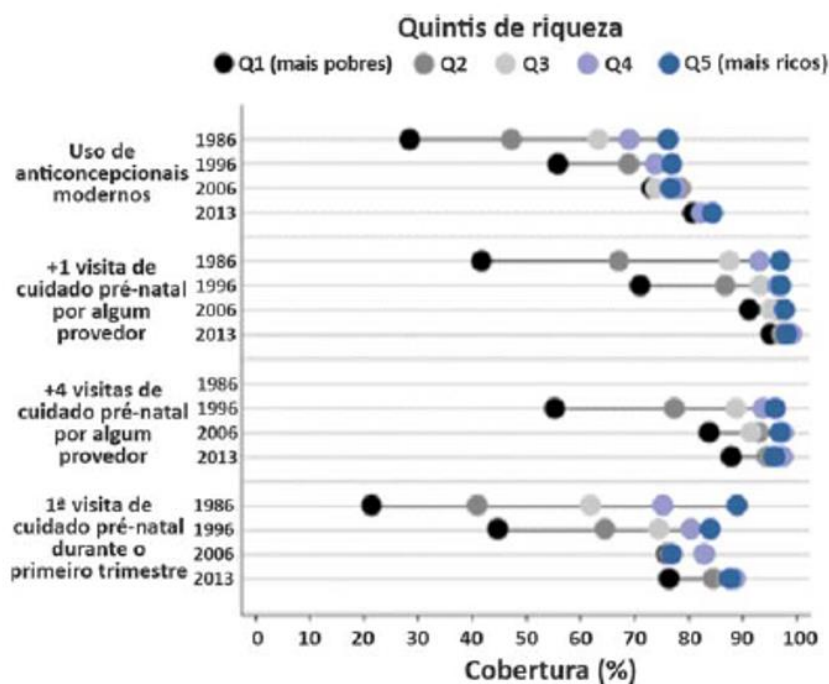
Questão 01

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, foram aprovadas duas leis, pelo Congresso Nacional, que são chamadas de leis orgânicas do SUS. Uma delas, a lei n. 8.142/1990, dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Considerando a legislação mencionada, para que o Governo Federal repasse recursos do SUS para estados e municípios, é necessária a existência de

- A) comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários e de prontuário eletrônico.
- B) plano diretor de regionalização e de conselho de saúde paritário.
- C) plano de saúde e de central de marcação de consultas e exames.
- D) fundo de saúde e de conselho de saúde paritário.

Questão 02

O gráfico a seguir demonstra a evolução das coberturas de indicadores de saúde materno-infantil em diferentes quintis de riqueza da população ao longo dos anos.



Disponível em: <<https://jigsaw.minhabiblioteca.com.br/books/9786558820437/epub/OEBPS/image/F01-19.jpg>>.

Com base na legislação do SUS, é correto afirmar que os dois princípios do SUS que têm relação mais direta com a evolução desses indicadores ao longo dos anos são a

- A) equidade e a integralidade.
- B) universalidade e a equidade.
- C) universalidade e a regionalização.
- D) participação social e a hierarquização.

Questão 03

Uma paciente de 23 anos, G3 P3, sem antecedentes mórbitos, procura atendimento em ambulatório de planejamento familiar manifestando desejo de laqueadura tubária. Durante a consulta, refere não desejar orientações sobre outros métodos por já estar decidida. De acordo com a lei de planejamento familiar, o profissional de saúde deverá

- A) prescrever contraceptivo hormonal, pois a paciente não se enquadra nos casos permitidos pela legislação brasileira para laqueadura tubária.
- B) informar a paciente de que é necessária a autorização expressa do cônjuge para a realização da laqueadura tubária.
- C) oferecer informações sobre outros métodos anticoncepcionais para que a paciente possa fazer livre escolha entre métodos reversíveis e irreversíveis.
- D) ofertar orientações sobre métodos anticoncepcionais reversíveis, pois a paciente não se enquadra nos casos permitidos pela legislação brasileira para laqueadura tubária.

Questão 04

Um homem de 78 anos é acompanhado por médico de família em visitas domiciliares, por ser acamado desde que ficou hemiplégico, em decorrência de acidente vascular cerebral (AVC) aos 75 anos. É portador de hipertensão arterial sistêmica (HAS) controlada e de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) com exacerbações progressivamente mais frequentes. Na última, há 4 meses, foi

necessário realizar internação hospitalar, ventilação não invasiva e antibioticoterapia sistêmica. Há 2 dias, segundo seu prontuário e familiares, apresentou tosse persistente, febre baixa e desconforto respiratório. O médico identificou, ao exame físico, panturrilhas livres e D-dímero normal e, à ausculta pulmonar, crepitações em ambos campos pulmonares. Foi prescrito, ao paciente, tratamento por meio de antibioticoterapia via oral e de dose elevada de corticosteroide inalatório. Hoje foi encontrado morto em seu quarto por um familiar que relatou piora da febre e do cansaço na madrugada anterior. Seu médico de família foi chamado para emissão de atestado de óbito. O médico fez a avaliação clínica do corpo, verificando ausência de sinais de traumas e constatando o óbito. Considerando o caso descrito, assinale a alternativa que apresenta quem deve preencher o atestado de óbito e as causas básicas, antecedentes e contribuintes dele.

- A)** O legista; causa básica: exacerbação de DPOC; causa antecedente: AVC; causas contribuintes: pneumonia, HAS e hemiplegia.
- B)** O legista; causa básica: sepse; causa antecedente: insuficiência respiratória; causas contribuintes: DPOC, HAS e sequela de AVC.
- C)** O médico de família; causa básica: broncopneumonia; causa antecedente: DPOC; causas contribuintes: HAS, hemiplegia e AVC.
- D)** O médico de família; causa básica: parada cardiorrespiratória; causa antecedente: pneumonia; causas contribuintes: DPOC, hemiplegia e AVC.

Questão 05

Um paciente de 70 anos, vítima de acidente vascular cerebral, sem sequelas, vai a uma consulta de retorno após receber alta hospitalar. O médico da unidade básica de saúde, ao analisar o caso do paciente, prescreve aspirina 100 mg para uso diário.

Nesse caso, o médico prescreveu esse medicamento a fim de evitar um novo evento cardiovascular, realizando, então, uma prevenção

- A)** primária.
- B)** terciária.
- C)** secundária.
- D)** quaternária.

Questão 06

Uma associação de pacientes ostomizados de um município pressiona os gestores de saúde para a disponibilização — ou para o financiamento — de bolsas e de capacitação em cuidados com ostomias na atenção primária em saúde. Diante disso, uma médica de uma unidade básica de saúde decide levar a proposta para a reunião do conselho municipal de saúde (CMS).

Nesse caso, no que diz respeito ao funcionamento desse conselho, é correto afirmar que

- A)** A discussão a respeito dessa proposta deve ser feita na secretaria de saúde municipal, uma vez que a prerrogativa de proposição de novos serviços é do poder executivo.
- B)** a participação da associação é vedada nas reuniões, considerando-se que os participantes dos conselhos são trabalhadores e gestores da área da saúde.
- C)** a aprovação da capacitação em cuidados com ostomias é possível, diferentemente da aprovação de novos gastos, tais como compra de bolsas de ostomias.
- D)** a viabilização da execução do plano cabe à secretaria de saúde, no caso de aprovação da proposta pelo CMS.

Questão 07

Uma médica, ao assumir seu cargo em uma unidade básica de saúde, observa alta incidência de pacientes fumantes na comunidade. Visando obter redução importante do tabagismo nesta comunidade ela estabelece um plano de ação. Considerando as orientações do Ministério da Saúde para o tabagismo, assinale a alternativa que, apresenta a estratégia mais efetiva e viável.

- A) Implementar consultas individuais semanais para os fumantes, fornecendo orientações personalizadas.
- B) Promover campanha semanal contra o tabagismo, ofertando palestras sobre seus malefícios.
- C) Organizar grupo de apoio para cessação do tabagismo, com encontro semanal no primeiro mês.
- D) Realizar visitas domiciliares semanais para incentivar o uso de adesivo e de medicamentos.

Questão 08

Um escolar de 8 anos é levado à consulta de rotina por sua mãe, que relata estar preocupada com o desenvolvimento de seu filho. Relata ter sido alertada pela escola que o menino tem comportamento bastante impulsivo e indisciplinado, que não demonstra interesse pelas atividades desenvolvidas em sala, que não termina as tarefas propostas e que atrapalha os demais alunos com conversas frequentes ou com brincadeiras. Ela conta que ele é, de forma geral, desatento, agitado e desmotivado. Relata que desde os 4 anos ele tem esse tipo de comportamento e que, em algumas ocasiões, ele reagiu agressivamente — mas nunca em ambiente escolar. À anamnese, percebe-se erro alimentar, com preferência por alimentos açucarados e por carboidratos e, ao exame clínico, apresenta-se na faixa de sobrepeso, segundo a curva de índice de massa corpórea, sem outras anormalidades.

Considerando o quadro descrito, trata-se de um caso suspeito de

- A) transtorno oppositor-desafiador, deve-se realizar uma avaliação clínica e psicossocial completa, e o diagnóstico deve se basear em sintomas de desatenção, de irritação e de impulsividade, a partir de escalas variadas.
- B) transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, deve-se realizar uma avaliação clínica e psicossocial completa, e o diagnóstico deve se basear em sintomas indicativos de desatenção, de hiperatividade e de impulsividade, a partir de escalas validadas.
- C) transtorno oppositor-desafiador, deve-se realizar uma avaliação psiquiátrica completa, e o diagnóstico deve se basear em sintomas indicativos de desobediência, de atitudes de desafio e de hostilidade contra figuras de autoridade, a partir de escalas validadas.
- D) transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, deve-se realizar uma avaliação psiquiátrica completa, e o diagnóstico deve se basear em sintomas indicativos de desatenção, de dificuldade em aceitar regras e de irritação, a partir de escalas validadas.

Questão 09

Uma primigesta de 28 anos, com idade gestacional de 25 semanas e 4 dias, foi atendida por uma equipe de saúde da família fluvial. Na avaliação, ela se queixou de tosse há 5 dias, associada a anosmia, febre de 38,2 °C e dispneia. Segundo familiares, ela recebeu apenas a primeira dose da vacina contra Covid-19. O quadro clínico dessa paciente evolui com insuficiência respiratória aguda e óbito. Diante disso, é realizado parto cesáreo de urgência e a criança nasce com 450 g e 20 cm, apresentando batimentos cardíacos e movimentos respiratórios por 10 segundos, sendo constatado óbito do bebê após esse período. A paciente havia realizado apenas uma consulta de pré-natal, assim que descobriu a gestação, não tendo sido identificadas alterações nos exames realizados à época. Como esses eventos devem ser considerados para o cálculo dos indicadores de mortalidade e natalidade?

- A)** A morte da gestante não será contabilizada no cálculo da mortalidade materna; a criança será contabilizada no cálculo da natalidade e da mortalidade neonatal precoce.
- B)** A morte da gestante será contabilizada no cálculo da mortalidade materna; a criança será contabilizada apenas no cálculo da mortalidade perinatal, não contribuindo para a natalidade.
- C)** A morte da gestante não será contabilizada no cálculo da mortalidade materna; a criança será contabilizada apenas no cálculo da mortalidade infantil, não contribuindo para a natalidade.
- D)** A morte da gestante será contabilizada no cálculo da mortalidade materna; a criança será contabilizada no cálculo da natalidade e da mortalidade infantil neonatal precoce.

Questão 10

Em uma reunião de equipe de saúde da família, os profissionais discutem as dificuldades de organização do atendimento no modelo de agendamento adotado pela secretaria municipal da saúde. Nesse modelo, no início do período, todas as vagas estão preenchidas com consultas pré-agendadas e os casos eventuais e urgentes são inseridos em agendamento duplo. Isso tem causado atrasos no fechamento da unidade no fim da tarde, pois o médico precisa encaixar os pacientes não agendados previamente em algum horário durante o dia. A equipe se queixa do estresse no acolhimento dos pacientes, e que são expostos a muitas reclamações na sala de espera. Também é apontado o número excessivo de faltas entre os agendados. A equipe, então, decide mudar o sistema de agendamento, reservando 40% das vagas para consultas de urgência, devido à alta demanda desse tipo de atendimento na comunidade, e 60% para consultas pré-agendadas. Dessa forma, pretende-se oferecer cuidado estruturado tanto para os pacientes com condições crônicas como para aqueles com condições agudas. Considerando os sistemas de agendamento, qual foi a mudança proposta pela equipe e qual o desafio frente à proposta escolhida?

- A)** Transição do modelo tradicional para o modelo carve-out, o que pode gerar desperdício das vagas não preenchidas por erro no dimensionamento da demanda.
- B)** Transição do modelo carve-out para o acesso aberto, o que pode criar longo tempo de espera para se conseguir o agendamento e aumentar a taxa de faltosos.
- C)** Transição do modelo tradicional para o acesso avançado, o que demanda educação permanente, compartilhamento de responsabilidades e comprometimento da equipe.
- D)** Transição do modelo carve-out para o acesso avançado, o que pode ocasionar longos atrasos, perda da longitudinalidade do cuidado e redução do tempo de consulta.

Questão 11

O tabaco, em seus múltiplos usos, configura-se como a principal causa evitável de morte no Brasil e no mundo. Estima-se que o tabagismo seja a causa para cerca de 40% das mortes por câncer; de 70 a 95% das mortes devido a câncer de pulmão e 75% dos óbitos decorrentes de doença pulmonar obstrutiva crônica. Para apoiar o seu enfrentamento pode-se adotar, isoladamente ou de forma combinada, diversos tipos de abordagens.

Sobre o tratamento a pessoa tabagista, é correto afirmar que

- A)** esquemas de aconselhamentos de maior intensidade e de intervenções breves apresentam probabilidade semelhante de ajudar o paciente a cessar o hábito de fumar.
- B)** o aconselhamento e a medicação são efetivos quando usados conjuntamente, mas ineficazes na promoção da abstinência ao tabagismo quando utilizados de forma isolada.
- C)** pacientes com elevada, ou muito elevada, dependência física devem iniciar tratamento medicamentoso com a associação de terapia de reposição de nicotina a bupropiona.
- D)** intervenções em grupo promovem a abstinência ao tabagismo pela interação e apoio mútuo entre os participantes e pela participação ativa do fumante e do profissional de saúde.

Questão 12

Mulher de 34 anos, com 4 filhos, desempregada, comparece a uma unidade básica de saúde (UBS) com queixa de atraso menstrual de um mês. Durante a consulta, a paciente relata que está muito aflita, por ter realizado um teste de gravidez cujo resultado foi positivo. Afirma que compareceu à consulta porque não deseja essa gravidez. Quando questionada, a paciente nega qualquer situação de violência sexual. Nesse caso, além de acolher e acalmar a paciente, a melhor abordagem a ser realizada pelo médico deve ser

- A) iniciar o pré-natal regular, mencionando a possibilidade de entrega voluntária da criança para adoção após seu nascimento.
- B) desencorajar a realização de um aborto, apesar da paciente ter direito, enfatizando os riscos à saúde advindos do procedimento de abortamento, como hemorragia, infecção, perfuração uterina, infertilidade e morte.
- C) assegurar o direito às informações clínicas e legais adequadas, garantir o sigilo e informar sobre sintomas que justifiquem a busca de atendimento médico em caso de realização de um aborto inseguro.
- D) questionar abertamente sobre a intenção de abortar, sem julgamento, e informá-la que tem obrigação ética de fazer um boletim de ocorrência caso o aborto venha a ser realizado.

Questão 13

Mulher de 45 anos vai à unidade básica de saúde (UBS) reportando dificuldade para reduzir o consumo de cigarros. Refere fumar 20 cigarros por dia desde os 20 anos e que já tentou interromper o uso várias vezes. Relata, ainda, irritação e ansiedade quando reduz o consumo de tabaco. Diante desse caso, o plano terapêutico adequado para essa paciente consiste em

- A) A reposição de nicotina com redução gradual da dose.
- B) terapia comportamental associada à reposição de nicotina.
- C) terapia comportamental e cessação imediata do tabagismo.
- D) prescrição de benzodiazepínico e redução gradual do número de cigarros diários.

Questão 14

Menina de 6 anos é paciente do mesmo médico na unidade básica de saúde (UBS) desde que nasceu. Sempre foi uma criança alegre, saudável e sociável. Na última consulta, há cerca de 15 dias, o pai a trouxe porque ela estava com “dor de barriga”, mas a paciente permaneceu encolhida e calada todo o tempo, quase não deixando o médico examiná-la. Há 2 dias, a professora da criança procurou a equipe preocupada com a mudança de comportamento da criança. Relatou que foi informada sobre a existência de fotos íntimas da criança numa rede social. A mãe, quando chamada, relatou que está trabalhando e a criança tem ficado com o pai na maior parte do tempo. Nessa situação, além da avaliação clínica, o médico deve

- A) registrar, em prontuário, dados clínicos de forma isenta de interpretações pessoais; notificar violência no SINAN e contatar os equipamentos sociais e conselho tutelar para o seguimento do caso juntamente com a equipe.
- B) encaminhar a criança à perícia médica mais próxima da unidade, onde será realizado exame físico mais detalhado e coleta de vestígios da violência; confirmar a violência antes da notificação no SINAN e contatar o conselho tutelar.

- C) confrontar os dados relatados pela professora com os pais, questionando-os sobre a denúncia e demonstrando preocupação; orientar as medidas de apoio à criança e à família.
- D) anotar, em prontuário, os dados da história com suspeita de abuso e denunciar o caso na delegacia mais próxima; encaminhar a criança para um serviço de proteção social local.

Questão 15

Homem de 44 anos é levado à sala de emergência do pronto-socorro apresentando agitação intensa, confusão mental, tremores generalizados e sudorese profusa. Ao exame físico verifica-se frequência cardíaca de 110 bpm e pressão arterial (PA) de 150 x 110 mmHg. O paciente é etilista crônico, sem antecedentes patológicos e seus familiares relatam que ele interrompeu o consumo de álcool há 48 horas. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o diagnóstico correto e a conduta inicial para esse paciente.

- A) Delirium tremens; administração de antipsicóticos, como haloperidol.
- B) Delirium tremens; administração intravenosa de benzodiazepínicos, como diazepam.
- C) Encefalopatia hipertensiva; restrição de líquidos e monitoramento estrito da função renal.
- D) Encefalopatia hipertensiva; administração de nitroprussiato de sódio para redução da PA média entre 20 e 25% nas primeiras 2 horas.

Questão 16

Um casal consulta com o médico de família e comunidade devido à preocupação da esposa com marido, que tem demonstrado compulsividade relacionada ao consumo de pornografia. Isso tem gerado discussões constantes entre eles, pois o homem é motorista por aplicativo e está deixando de trabalhar devido a este padrão de comportamento — o que tem impactado na situação financeira da família, que já é difícil. Ele relata que a prática começou como distração e alívio do estresse, mas admite que tem dificuldades para controlar esses comportamentos e reconhece as consequências que isso tem gerado para seu contexto familiar. Durante a consulta, o médico identifica sinais de baixa autoestima e de ansiedade nesse paciente.

Diante desse relato, qual é o grau de motivação do paciente para a mudança de comportamento?

- A) Ação, visto que já planeja e cria condições para que uma mudança comportamental ocorra.
- B) Contemplação, visto que admite o problema e é ambivalente em relação ao seu comportamento.
- C) Pré-contemplação, visto que reconhece o impacto do vício em seu relacionamento e em sua família.
- D) Preparação, visto que sua percepção sobre os efeitos do vício ainda é limitada, sem possibilidade de mudança.

Questão 17

Enchentes, secas, ondas de calor, tempestades tropicais, incêndios florestais e aumento do nível do mar estão diretamente relacionados à escalada dos determinantes sociais da saúde. Esses fatores podem levar ao aumento de doenças cardiovasculares, entre outras. Considerando a interferência desses fatores, assinale a alternativa correta com relação às ações de promoção da saúde.

- A) A exposição à poluição do ar pode acarretar no aumento do risco para hipertensão, diabetes e dermatite atópica, portanto, indica-se fechar as janelas da residência nos horários de maior fluxo de carros a fim de reduzir a exposição aos poluentes.
- B) As plantações de milho para a produção de biocombustível configuram uma importante tendência no país uma vez que aumentam a oferta de empregos na economia verde e melhoram as condições de vida de pequenos e médios produtores rurais.
- C) A elevação da pressão arterial é um efeito comum das ondas de calor, por isso, é indicado aumentar

as doses dos anti-hipertensivos, reforçar a hidratação e procurar fontes de sombra e refrigeração.

D) As atividades de educação em saúde acerca do estresse climático são desaconselháveis nas escolas, devido ao risco de sofrimento emocional nas crianças e nos adolescentes.

Questão 18

Paciente do sexo feminino, 33 anos, previamente saudável, após ter sido submetida a abdominoplastia em clínica privada, evoluiu com instabilidade hemodinâmica no pós-operatório imediato antes da alta. O cirurgião plástico que a operou pediu à família da paciente que a levasse para a unidade de pronto atendimento, onde chegou sem vida. À luz do Código de Ética Médica, deve-se considerar que o cirurgião plástico da situação descrita foi

A) imprudente ao operar a paciente em clínica privada.

B) imperito ao realizar o procedimento de abdominoplastia.

C) negligente quanto à estabilização pré-transporte da paciente.

D) diligente ao solicitar aos familiares a rápida transferência da paciente.

Questão 19

Um médico de família e comunidade, atuante numa equipe fluvial, atende a uma população ribeirinha e a uma população indígena, ambas na região amazônica. Ele reconhece que essas duas populações vivem em regiões remotas. No entanto, é notável que elas apresentam diferenças culturais e de modos de vida. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta a estratégia adequada a ser adotada pelo médico e por sua equipe no cuidado à saúde das populações mencionadas.

Assinale a opção que apresenta ações do processo de trabalho das eMulti.

A) Utilização de profissionais de saúde nativos ou locais sem a necessidade de capacitação específica focada no paradigma biomédico, uma vez que eles já conhecem profundamente a cultura, as tradições e os hábitos dessas populações.

B) Atendimento à população ribeirinha centrado em soluções biomédicas e tecnológicas, utilizando conhecimentos da medicina ocidental, enquanto o atendimento à população indígena deve ser pautado por suas próprias práticas de cuidado e cura.

C) Incentivo e valorização das práticas de cuidado tradicionais, promoção do uso racional de medicamentos básicos pela população indígena e estímulo à participação local e à integração do saber acadêmico e do senso comum da comunidade ribeirinha.

D) Organização dos atendimentos das populações de forma padronizada, a partir da identificação das prioridades em saúde, considerando que as comunidades compartilham realidades geográficas e desafios semelhantes em relação ao acesso a cuidados médicos.

Questão 20

Mulher de 24 anos, previamente saudável, portadora de rim único, sofreu um acidente motociclístico há 7 dias. Foi levada a um hospital, onde foi submetida a craniectomia descompressiva e drenagem de hematoma subdural agudo. No entanto, há 1 dia, evoluiu com coma aperceptivo e ausência de reflexos de tronco encefálico. Diante disso, foi realizado o protocolo de morte encefálica, com confirmação diagnóstica. Testes laboratoriais mostraram função renal preservada, anti-HBs positivo e HBsAg negativo. Embora a paciente seja doadora de órgãos e tecidos, seu esposo se posiciona contra a doação, afirmando que isso interferirá em suas crenças. Com base na legislação pertinente, assinale a alternativa correta quanto à doação de órgãos nessa situação.

- A) A condição renal da paciente, embora seja saudável, contraindica a doação de órgãos.
- B) A doação de órgãos da paciente requer o consentimento e a autorização de seu esposo.
- C) O poder público poderá intervir a favor do cumprimento do desejo de doação da paciente.
- D) Os resultados dos exames laboratoriais citados impossibilitam a doação de órgãos da paciente.

Questão 21

Um médico recém-contratado para atuar como gerente de uma unidade básica de saúde (UBS) em uma cidade com 35.000 habitantes agendou uma reunião com a equipe para tratar de visitas domiciliares. Seu objetivo é propor uma investigação com enfoque em doenças crônicas não transmissíveis, na população residente com 18 anos ou mais de idade. O médico visa melhorar, em um curto período de tempo, o planejamento de cuidados de saúde dessa população. O desenho de pesquisa mais adequado para esse levantamento denomina-se

- A) estudo transversal.
- B) estudo experimental.
- C) análise de caso-controle.
- D) análise de coorte prospectivo.

Questão 22

Homem de 61 anos procura uma unidade básica de saúde (UBS) de uma cidade grande desejando receber um pedido para colonoscopia, pois ouviu que é um exame preventivo necessário após os 50 anos de idade para detecção de câncer do intestino. Questionado pela médica da UBS, o paciente relata que não apresenta sintomas gastrointestinais, anemia, perda de peso ou histórico familiar de câncer de intestino. Considerando-se que neste município existe ampla disponibilidade de recursos diagnósticos, e levando em conta as políticas públicas do Ministério da Saúde para rastreamento, que conduta inicial a médica deverá adotar nesse caso?

- A) Fornecer o pedido de colonoscopia para diagnóstico precoce ao paciente, para que ele busque realizar o exame no SUS por meio de ação judicial.
- B) Solicitar colonoscopia para diagnóstico precoce e informar o paciente da possível demora para sua realização, visto que não há suspeita de câncer.
- C) Solicitar exame de sangue oculto nas fezes, informando o paciente de que se trata de um exame indicado pelo SUS para rastreio de câncer do intestino.
- D) Esclarecer que o SUS não prevê a realização de colonoscopia para rastreio de câncer de intestino e orientar o paciente a realizar o exame no setor privado.

Questão 23

Mulher comparece na unidade básica de saúde (UBS) com seus dois filhos, um menino de 8 anos e uma menina de 13 anos, buscando orientações quanto à vacinação contra o HPV.

Diante desse quadro, qual a orientação correta?

- A) O menino e a menina podem receber dose única nessa visita.
- B) O menino e a menina podem receber a primeira dose nessa visita e agendar a segunda dose em 60 dias.
- C) A menina não deve ser vacinada e o menino poderá receber a primeira dose ao completar 11 anos.
- D) A menina pode ser vacinada em dose única nessa visita e não há indicação para que o filho seja vacinado agora.

Questão 24

Mulher de 55 anos, ao visitar seu pai, de 82 anos, com Doença de Alzheimer, em uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI), suspeita de maus-tratos, uma vez que o encontrou restrito ao leito, com fraldas sujas e fâcias de dor. Ela já havia presenciado outros idosos residentes passarem por situações semelhantes a essa na mesma instituição. Ao ser questionada, a equipe responsável responde que a restrição de mobilidade no leito foi efetuada porque o paciente se encontrava agitado pela manhã. Quanto à higiene do idoso, a equipe alega falta de profissionais para realizar as trocas de fraldas. Tendo em vista o que dispõe o Estatuto do Idoso, de que maneira a situação descrita pode ser qualificada?

- A) A decisão dos familiares de manter o paciente em uma ILPI configura ato de violência contra o idoso.
- B) A situação descrita é justificável do ponto de vista institucional por se tratar de paciente agitado e com demência.
- C) A presença de negligência, caracterizada pela omissão na prestação de cuidados, configura-se como uma forma de violência institucional.
- D) A situação caracteriza violência patrimonial, pois os recursos financeiros do idoso não estão sendo empregados para garantir os cuidados de que necessita.

Questão 25

Paciente de 38 anos, morador de uma zona urbana não endêmica e sem história de viagens recentes para regiões de risco, vai à unidade básica de saúde (UBS) apresentando histórico vacinal de febre amarela há 9 anos. Ele relata ao médico que um macaco foi encontrado morto perto de sua casa. Diante desse relato, o médico deve

- A) salientar a ausência de risco de febre amarela, uma vez que o Brasil não é país endêmico.
- B) informar que é desnecessário realizar reforço para a vacina contra febre amarela nesse caso.
- C) solicitar e aguardar resultado do anatomopatológico do animal, a fim de confirmar febre amarela.
- D) indicar o reforço da vacina contra febre amarela, independentemente da ministração da última dose.

Questão 26

Durante uma roda de conversa em uma sala de espera com mães que aguardavam a consulta de seus filhos com um médico de família e comunidade, uma enfermeira da equipe de saúde da família propôs a discussão do tema da hesitação vacinal. Durante o diálogo, uma das participantes afirmou que “a culpa de tudo isso é da Internet”.

Considerando essa situação, assinale a alternativa correta, acerca dos argumentos a serem utilizados pela enfermeira nessa conversa com a comunidade.

- A) A Internet veicula dúvidas quanto à real eficácia/eficiência e segurança das vacinas, o que abala a confiança da população nos imunobiológicos; ademais, o algoritmo das redes sociais associa temas antivacinação a outros temas de natureza moral, fazendo exposição seletiva.
- B) A hesitação vacinal ocorre nos extratos sociais de menor renda, que são contrárias à medicalização da saúde e acreditam que hábitos de vida saudáveis protegem contra doenças e garantem saúde, dispensando a necessidade de vacinação.
- C) O paradoxo epidemiológico de que algumas doenças imunopreveníveis hoje são raras, associado à complexidade do calendário vacinal, criou a política de redução temporária do uso de algumas vacinas em determinado ano para aumentar o engajamento da população no ano seguinte.

D) A circulação de informações falsas (fake news), impulsionada pela internet, causa pouco impacto nas escolhas da população de menor poder aquisitivo, que tende a ter mais confiança na vacinação e menor acesso às redes sociais.

Questão 27

Diante de um novo teste diagnóstico para hanseníase, que está sendo aplicado em uma unidade básica de saúde (UBS), o médico julga pertinente iniciar uma capacitação com sua equipe sobre a validade de testes diagnósticos, medidas de sensibilidade, especificidade e valores preditivos. Então, ele apresenta os seguintes dados a sua equipe: dentre 100 pessoas acometidas por hanseníase, 98 são verdadeiros positivos; e, dentre 100 pessoas não acometidas por hanseníase, 90 são verdadeiros negativos. A partir desses dados, é correto afirmar que o valor de sensibilidade do teste é

- A) 90%.
- B) 90,7%.
- C) 97,8%.
- D) 98%.

Questão 28

Ao assumir a coordenação de uma equipe de saúde da família, um médico de família e comunidade percebe que sua equipe não utiliza critérios para estabelecimento de fluxo de agendamento de visitas domiciliares. Diante dessa situação, ele decide promover uma roda de conversa a fim de sensibilizar sua equipe acerca da necessidade de organizar critérios para a definição das visitas domiciliares como uma abordagem ao indivíduo em seu aspecto familiar e comunitário.

Nesse caso, qual é o princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que melhor se enquadra na estratégia adotada para melhoria do trabalho da equipe?

- A) Equidade.
- B) Autonomia.
- C) Integralidade.
- D) Universalidade.

Questão 29

Um gestor municipal de saúde, ao perceber um significativo aumento de tabagismo entre os adolescentes em seu município no último ano, resolveu adotar estratégias para o combate ao uso do tabaco em sua região. A partir dessas informações, assinale a opção que apresenta as estratégias prioritárias a serem adotadas para essa população.

- A) Orientação e prescrição de medicamentos aos pacientes tabagistas, para auxiliar aqueles que ainda não manifestaram o desejo de cessação.
- B) Capacitação dos profissionais de saúde acerca do tratamento para cessação do tabagismo visando o atendimento de pacientes com desejo de parar de fumar.
- C) Organização de comitês nos bairros para regulação da venda e do uso de tabaco e promoção de ações em eventos para chamar atenção aos fatores de risco do uso de fumo.
- D) Encaminhamento dos fumantes para o nível de maior densidade tecnológica, considerando o difícil controle do tabagismo e a necessidade de melhores estratégias para essa ação.

Questão 30

Uma paciente com 70 anos, menopausa ocorrida aos 52 anos, queixa-se de sangramento vaginal de

pequena quantidade e intermitente, com 3 meses de evolução. Não tem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva e teve dois citopatológicos negativos consecutivos dos 59 até os 64 anos. O exame especular realizado na última consulta não demonstrou lesões aparentes. Está acompanhada pela filha, que afirma estar muito ansiosa, porque leu casos parecidos relatados na internet e acha que a mãe pode estar com "câncer de útero". A paciente é tabagista (1 maço/dia), há 40 anos, e apresenta história mórbida pregressa de hipertensão arterial sistêmica, em tratamento, e de intolerância glicêmica, em tratamento, via oral. Conta que pratica pilates 3 vezes por semana e que tem independência financeira e social, apresentando-se calma durante a consulta. Ao exame físico, encontra-se lúcida, orientada, contactuante e atenta. Seu IMC é de 30 kg/m². Os exames laboratoriais não apresentam particularidades. Informa que gostaria de decidir sobre sua saúde por conta própria. Considerando esse caso, o médico generalista da atenção primária deve

- A)** comunicar o quadro clínico à filha da paciente, que deverá se encarregar de explicá-lo à mãe, porque é idosa, e orientar que não serão necessários exames adicionais.
- B)** respeitar o direito à autonomia, privacidade e sigilo médico da paciente idosa, já que ela demonstra ser capaz de autogerir-se, e solicitar ultrassonografia transvaginal.
- C)** explicar que é obrigatória a presença de um responsável pela paciente, por ser idosa, para a continuidade do tratamento, e solicitar CA 125 e ultrassonografia transvaginal.
- D)** explicar que a família deve ser comunicada do ocorrido com a paciente e que, devido à idade, o tratamento é expectante, orientando que não serão necessários exames adicionais.

Questão 31

Um médico de família e comunidade, que atua em uma equipe de saúde da família fluvial focada em populações ribeirinhas, é convidado para atender uma população indígena de um distrito sanitário especial indígena (DSEI). Com relação a essas populações e ao território em que habitam, assinale a opção correta.

- A)** A delimitação dos DSEIs considera a distribuição demográfica tradicional, que pode não coincidir com os limites de estados; já o território das equipes de saúde da família ribeirinhas respeita esses limites.
- B)** As demarcações de áreas indígenas garantem a proteção contra conflitos e situações de vulnerabilidade, apesar de a distribuição de terras representar um problema a ser enfrentado pelas populações ribeirinhas.
- C)** A desnutrição infantil tem uma alta incidência nas populações indígenas, o que não ocorre frequentemente na população ribeirinha, dada a diversidade de alimentos disponíveis às margens dos percursos fluviais.
- D)** O principal recurso de atenção à saúde da população indígena ainda é o sistema tradicional de saúde; já na população ribeirinha, as práticas tradicionais e os cuidadores locais foram abandonados e substituídos por medicina alopática.

Questão 32

Durante uma visita domiciliar, o médico de família nota que a filha de 16 anos do casal visitado aparentava ser muito menor do que o vestido que usava. O casal concorda com a observação e afirma que a filha come pouco. A adolescente relata que não apresenta qualquer problema de saúde e que apenas procura se cuidar fazendo musculação e corrida diariamente, além de seguir as dietas que estuda nas redes sociais. A mãe refere que, seguindo a dieta atual, a filha havia perdido 7 kg em 1 mês. A adolescente nega vomitar após as refeições ou quaisquer problemas, exceto o fato de não menstruar há 4 meses, negando também ser sexualmente ativa. Ao exame físico, verificam-se altura de 1,7 metros e peso de 45 kg. Observa-se ainda que o exame físico da adolescente não apresenta

alterações, exceto aspecto emagrecido e palidez cutaneomucosa. Para esse caso clínico, o diagnóstico e o tratamento a serem considerados inicialmente são, respectivamente,

- A) bulimia nervosa; bupropiona.
- B) hipertireoidismo; propiltiuracil.
- C) anorexia nervosa; psicoterapia.
- D) transtorno de purgação; metoclopramida.

Questão 33

Um novo exame que detecta o DNA do *Mycobacterium leprae* em pacientes com suspeita de hanseníase está sendo testado. Ele demonstra capacidade de detectar 80% de pacientes com a doença e fornece resultado falso-positivo em 20% das pessoas sem a doença. Um médico de família e comunidade está utilizando esse exame em uma comunidade vulnerável na qual a prevalência de hanseníase é de 10%.

Nesse caso, qual é a probabilidade de um resultado positivo ser de um indivíduo realmente doente?

- A) 31%.
- B) 97%.
- C) 69%.
- D) 80%.

Questão 34

Um homem com 40 anos, apresentando queixa de perda constante de interesse e de prazer nas atividades das quais costumava gostar, relata: “não tenho vontade sequer de sair de casa”. Afirma que isso vem se mantendo nos últimos 2 meses, de forma constante e diária, mas que piorou no último mês. Conta que seus amigos e familiares também perceberam e vêm cobrando dele uma mudança de atitude. Além disso, diz que tem se sentido mais ansioso e inquieto e que apresentou 2 “crises” súbitas, há um mês, de duração de alguns minutos, em que sentiu medo intenso, taquicardia, sufocação, tontura, sudorese e sensação de que algo ruim iria acontecer e de que iria morrer. Não relaciona as crises a fatores desencadeantes ou a situações pelas quais esteja passando. Relata que, quando teve as crises, foi a um pronto-socorro, onde foram descartadas causas orgânicas para o quadro. Refere também que apresentou perda de peso considerável no último mês, mas não sabe de quanto, tendo percebido apenas por suas roupas. Diz ainda que está sem fome e que tem tido muito sono todos os dias e se sente sempre cansado, está sem concentração e tem dificuldade de pensar. Nega etilismo, tabagismo ou uso de drogas ilícitas, negando também doenças conhecidas. Ao exame físico, o paciente apresenta-se sem alterações, assim como não mostram alterações os exames recentes de hemograma, TSH, T4 livre que ele traz. Ao exame psíquico, apresenta-se colaborativo, atenção preservada, com memória e orientação sem alterações; humor deprimido e ansioso; pensamento de forma, curso e conteúdo sem alterações, assim como juízo e crítica. Não se verificam alterações senso perceptivas, observando-se discreta agitação psicomotora.

Considerando-se a situação descrita, qual é diagnóstico para o caso desse paciente?

- A) Transtorno de pânico com agorafobia.
- B) Transtorno bipolar em fase depressiva.
- C) Transtorno de ansiedade generalizada.
- D) Transtorno depressivo com ataques de pânico.

Questão 35

Em um distrito sanitário especial indígena, um médico atende a uma criança com 4 anos, com 23 kg,

que apresenta taquipneia, tosse, letargia, choro sem lágrimas e febre de 39,2 °C. Como tratamento, o paciente tem utilizado emplastos de ervas no peito. Diante desse quadro, após a avaliação do paciente, o médico precisa, por meio de intérprete, solicitar à mãe que

- A) conceda autorização para internar a criança mantendo os emplastos utilizados.
- B) retire os emplastos e inicie medicamento parenteral em regime de internação para a melhora do desconforto da criança.
- C) realize o tratamento em domicílio com ervas tradicionais de seu povo e que retorne em 7 dias.
- D) inicie uso de antibiótico em domicílio, com visitas da equipe médica, e que mantenha o uso do emplastro.

Questão 36

Os inquéritos populacionais de saúde têm sido cada vez mais utilizados não apenas para avaliar a eficácia dos serviços de saúde na perspectiva dos usuários, mas também como uma fonte de informações sobre morbidade referida e sobre estilo de vida saudável. A Pesquisa Nacional de Saúde foi um inquérito de saúde de base domiciliar, de âmbito nacional, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013 e em 2019. Essa pesquisa realizada pelo IBGE se caracteriza como um estudo do tipo

- A) coorte.
- B) transversal.
- C) experimental.
- D) caso-controle.

Questão 37

Um menino com 6 anos é encaminhado à unidade de estratégia de saúde da família pela escola em que estuda, por estar apresentando dificuldades de aprendizagem. A professora havia relatado para a mãe que o menino não conseguia progredir na memorização de letras e que não associava cores e imagens às palavras como fazem as demais crianças. Orientou, portanto, a realização de uma avaliação médica, pois desconfiava de que o menino tinha um transtorno de aprendizagem. Diante disso, o médico avalia o paciente e relata as seguintes observações sobre ele: face atípica sem estigmas de doenças genéticas; e ausência de doenças prévias, de distúrbio visual ou auditivo, de histórias de condições de morbidade perinatal, de alerta do desenvolvimento neuropsicomotor, de uso de medicamentos, de convulsões e de história de meningite. Acrescenta que o ambiente familiar é com pais trabalhadores e empregados e com um irmão de 9 anos do qual não há queixas escolares. Registra, ainda, que não foram identificados riscos ambientais, como alcoolismo, uso de drogas, depressão e outros transtornos.

Com base nessas informações, a conduta médica inicial adequada é encaminhar o paciente para uma

- A) avaliação psicopedagógica, a fim de identificar o transtorno de aprendizagem específico.
- B) reavaliação junto à escola, já que não há parâmetros para avaliar transtorno de aprendizagem aos 6 anos de idade.
- C) consulta com um neuropediatra, com o objetivo de identificar doenças que possam gerar transtornos de aprendizagem.
- D) equipe de reforço pedagógico, a fim de realizar acompanhamento, uma vez que a criança não apresenta problemas aparentes.

Questão 38

Um homem com 46 anos comparece à consulta acompanhado de sua esposa e solicita atestado para

justificar 2 dias de ausência no trabalho. Refere que, há 2 dias, apresenta diminuição do apetite, cefaleia, fadiga, tristeza e sentimento de culpa. A esposa refere que ele ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica numa festa e que chegou em casa sendo carregado por amigos na noite anterior ao início dos sintomas. Segundo ela, isso costuma acontecer há 1 ano, cerca de 2 vezes ao mês. Após essas situações, o paciente fica bastante entristecido, não quer sair da cama e acaba faltando ao trabalho. Entre os episódios de ingesta de bebida, o paciente trabalha, estuda e tem bom funcionamento familiar e social. Nega comorbidades e uso de medicações. Ao exame físico, não apresenta alterações. Nesse caso, ao final da consulta, o médico deve explicar ao paciente que seu quadro clínico trata-se de

- A) uso nocivo de álcool.
- B) dependência de álcool.
- C) episódio depressivo moderado.
- D) síndrome de abstinência do álcool.

Questão 39

Em um território com população em situação de vulnerabilidade, uma unidade básica de saúde possui duas equipes que atendem 9 000 pessoas cadastradas. Estima-se que as demandas por atendimento médico se tornarão ainda maiores, já que a população local está em rápida expansão, pois há ocupações em áreas próximas a um córrego que corta a extremidade do território de abrangência. Devido à sobrecarga dessas duas equipes e do potencial crescimento populacional, o gestor, portanto, decide implantar uma nova equipe de saúde da família. Nesse contexto, qual é a melhor estratégia para a nova equipe de saúde da família organizar o processo de territorialização?

- A) Dividir o território a partir da escala de risco familiar, a fim de distribuir as famílias vulneráveis de forma igualitária entre os agentes comunitários, evitando, assim, a sobrecarga de trabalho desses profissionais.
- B) Dividir o território em micro áreas, mesmo que de forma assimétrica geograficamente, garantindo maior semelhança das necessidades dos grupos nele contidos, a fim de facilitar o direcionamento das ações sociais e sanitárias.
- C) Utilizar mapas esquemáticos ou mapas-base impressos para a representação do território de abrangência e para a divisão do território em micro áreas, pois eles permitem melhor análise dos dados em relação ao geoprocessamento.
- D) Utilizar dados primários para a divisão do território em micro áreas, como bancos de dados do DATASUS e do IBGE, pois eles oferecem informações em níveis de desagregação suficientes para ajudar a estabelecer o diagnóstico situacional local.

Questão 40

O prefeito de um município brasileiro deseja implantar a Práticas Integrativas e Complementares (PICS) em sua cidade, para que os cidadãos tenham acesso a sessões de auriculoterapia, musicoterapia, entre outras PICS. Sobre as orientações expressas no referido programa do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que

- A) a acupuntura deve ser ofertada pela atenção especializada, com o acesso regulado para pacientes atendidos pela atenção primária.
- B) as PICS são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que regula quais destas práticas podem ser implementadas.
- C) as ações das PICS devem ter caráter multiprofissional, com a adoção de práticas que se adequem ao nível de atenção no qual estejam implementadas.
- D) a auriculoterapia deve ser inserida em todos os níveis de atenção em saúde, com ênfase na atenção

terciária, pois nesta, apresenta melhores resultados.

Questão 41

O caso de um homem de 72 anos é avaliado em reunião de equipe na unidade básica de saúde após uma visita domiciliar realizada pelo agente comunitário de saúde (ACS). A esposa, de 68 anos, ao perceber uma piora do quadro de incontinência urinária, associada à perda ponderal expressiva em 08 meses, levou o idoso ao urologista, do qual havia abandonado o seguimento do acompanhamento prévio da hiperplasia benigna prostática (HPB). A visita foi solicitada porque ao receber o diagnóstico de neoplasia de próstata avançado sem possibilidade de cura, a esposa percebeu o desinteresse do idoso em realizar tarefas cotidianas e para tomar banho, se levantar da cama e se vestir, além da falta de apoio, em relação aos cuidados com o pai, da filha do casal, uma mulher de 33 anos que dá muito trabalho, segundo a mãe. O ecomapa exibido a seguir foi construído pelos membros da equipe, considerando outras informações colhidas pelo ACS durante à visita domiciliar.

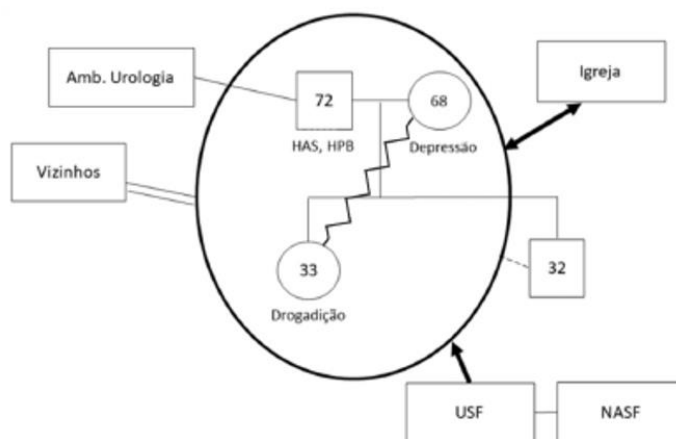


Figura — Genograma elaborado pela equipe de Saúde da Família.

Figura — Ecomapa elaborado pela equipe de Saúde da Família.

Legenda: NASF — Núcleo Ampliado de Saúde da Família; Amb. — Ambulatório; USF — Unidade de Saúde da Família.

A partir das informações apresentadas no texto e no ecomapa, a equipe de saúde da família deverá

- A) desenvolver um projeto terapêutico singular definitivo para a esposa se orientar e seguir, pois o idoso se encontra sem perspectiva de cura.
- B) sugerir a internação compulsória para tratamento da filha do casal, diminuindo a quantidade de problemas que a esposa do idoso precisará gerenciar nesta fase.
- C) reconhecer a dinâmica de funcionamento familiar, detectando disfuncionalidades e planejar intervenções precoces na busca do reequilíbrio dessa estrutura de relações.
- D) sugerir a internação do idoso em um serviço de cuidados paliativos para possibilitar que uma equipe de paliativismo preparada possa gerenciar o cuidado prestado.

Questão 42

Um menino de 6 meses e 15 dias é trazido pela mãe em consulta de puericultura na unidade básica de saúde. A criança recusa papas sólidas e aceita apenas o leite materno. Revisando consultas anteriores, o médico de família e comunidade identifica que a mãe já havia demonstrado preocupação, pois a criança ainda não apresentava sorriso social, não observava a mãe nem olhava nos seus olhos enquanto mamava, não se interessava por outras crianças, não respondia a chamados e não

apresentava nenhum tipo de lalação. Por isso, a criança foi encaminhada para investigação com um otorrinolaringologista, o qual não identificou nenhum déficit auditivo. A mãe, de 39 anos, apresentou diabetes gestacional.

Diante desse quadro, a conduta do médico de família deve ser

- A)** manter rotina de puericultura e estimulação adequada e precoce por equipe multidisciplinar até 24 meses.
- B)** rastrear transtorno do espectro autista nessa criança, para descartar essa condição, antes de referenciá-la para a atenção especializada.
- C)** acompanhar o desenvolvimento da criança até os 16 meses de idade, pela ausência de sinais de alerta sugestivos de transtorno do espectro autista.
- D)** referenciar a criança para atenção especializada, para acompanhamento, investigação e planejamento terapêutico em conjunto com a atenção primária.

Questão 43

Um homem de 30 anos é atendido em unidade básica de saúde com queixa de alteração no padrão do sono, alternando noites de insônia com noites de sono inquieto há 7 meses. Sente-se preocupado, com medo excessivo de adoecer ou de algo desagradável ocorrer. Seus amigos o consideram inquieto, tenso, irritado e com dificuldade de se concentrar. Ele relata que mantém suas atividades profissionais normalmente.

Diante desse quadro, qual é o diagnóstico mais provável?

- A)** Depressão maior.
- B)** Transtorno bipolar do humor.
- C)** Transtorno de ansiedade generalizada.
- D)** Transtorno do déficit da atenção em adulto.

Questão 44

Durante uma consulta de rotina com o médico da unidade básica de saúde, uma adolescente de 15 anos relata ter iniciado sua vida sexual com o namorado de mesma idade. Ela refere que têm usado preservativo, porém sente-se insegura e gostaria de iniciar o uso de anticoncepcionais orais, assim como suas amigas já o fazem. A paciente não apresenta queixas e não tem antecedentes patológicos pessoais ou familiares. Frequenta o primeiro ano do ensino médio e relata que não gostaria de informar seus pais sobre as questões de sua sexualidade. Considerando o Código de Ética Médica e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta correta do médico, nesse caso, é

- A)** optar por não prescrever a anticoncepção oral, uma vez que a adolescente pretende usar pílula para evitar a gravidez e estará arriscada a contrair infecções sexualmente transmissíveis, caracterizando imaturidade psicológica e risco para si; ele deve reforçar, também, a prática sexual segura e, devido ao risco iminente à saúde da adolescente, está obrigado a informar os responsáveis sobre o motivo da consulta.
- B)** ponderar sobre a prescrição de anticoncepção, pois a busca pelo aconselhamento médico é um indício de decisão madura, sendo provável que, em caso de recusa da prescrição, a paciente decida se automedicar; ele deve, também, aproveitar esse momento para abordar a prática sexual segura, assim como deve incentivar o fortalecimento dos laços de comunicação familiar sobre as decisões da adolescente.
- C)** decidir por não prescrever a anticoncepção oral, uma vez que não consegue, com base na consulta, julgar a maturidade da adolescente, podendo ser responsabilizado em caso de uso inadequado e de gravidez subsequente; ele deve aproveitar o momento para abordar a prática sexual segura e para manter os princípios de confidencialidade sobre a consulta, já que não há risco de vida iminente.

D) considerar a prescrição de anticoncepção, visto que a menina já iniciou atividade sexual, aproveitando o momento, também, para abordar a prática sexual segura; ele deve comunicar a adolescente de que o assunto será tratado com seus pais, uma vez que os menores de 16 anos são classificados como “absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil”.

Questão 45

Após assumir a gestão da saúde municipal, um médico encontra a seguinte situação de saúde: uma população de 30 mil habitantes, com faixa etária predominante de 20 a 50 anos, com predomínio de doenças crônicas não transmissíveis e de causas externas, principalmente por acidentes. O município possui cobertura de atenção primária de 70%, com sete equipes de saúde da família em áreas de maior vulnerabilidade e nas áreas menos vulneráveis, uma unidade básica de saúde tradicional. A partir desses dados, o médico reúne a equipe de planejamento para construir o plano municipal dos próximos 4 anos.

Com base nessas informações, qual deve ser a ação prioritária contemplada no plano?

A) Ampliação da cobertura da atenção primária com maior integração com atenção secundária de forma a melhorar os indicadores das doenças crônicas e a ampliar a resolubilidade do Sistema Único de Saúde.

B) Manutenção da cobertura de saúde da família, priorizando a criação de um serviço de urgência e de emergência em área mais vulnerável, considerando as necessidades de saúde.

C) Aumento dos serviços de saúde de atenção primária tradicional pela necessidade de ampliar o acesso dos usuários ao sistema de saúde sem estratégia de saúde da família.

D) Aquisição de novas ambulâncias para facilitar as remoções de pacientes para os municípios vizinhos e os fluxos dos usuários nas urgências, ampliando o acesso à saúde.

Questão 46

Um homem de 59 anos comparece à unidade básica de saúde com queixas de dispneia aos esforços físicos e de tosse seca, os quais se desenvolveram gradualmente ao longo dos últimos anos. Ele relata sono e apetite normais, no entanto refere febre e perda de mais de 5% do peso corporal nos últimos 2 meses. Menciona que é divorciado e que está tendo dificuldades para encontrar emprego desde que o local onde trabalhava encerrou suas atividades. Paciente apresenta tomografia computadorizada de tórax com espessamento da pleura visceral e parietal, derrame pleural e formação de placas pleurais. Considerando o contexto clínico-epidemiológico desse caso, é correto afirmar que o paciente trabalhava na

A) agricultura (com agrotóxico).

B) construção civil (com amianto).

C) fabricação de solventes químicos (com benzeno).

D) extração do carvão (com poeira do carvão mineral).

Questão 47

Observe a imagem a seguir.



Jornal O Tempo, Edição de 21 jan. 2013.
Disponível em: otempo.com.br/charges. Acesso em 30 abril de 2023.

Em relação aos pressupostos e às características do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Atenção Primária em Saúde (APS), a charge apresentada está relacionada a problemas de

- A) descentralização e de hierarquização, uma vez que muitas pessoas gostariam de ser atendidas ao mesmo tempo, em um só lugar.
- B) acessibilidade e de gestão, uma vez que o subfinanciamento e o subgerenciamento podem explicar as longas filas para acesso ao sistema.
- C) resolubilidade e de integralidade, uma vez que os pacientes a serem atendidos primeiro terão maior chance de terem seus problemas resolvidos.
- D) universalidade e de coordenação do cuidado, uma vez que o paciente “menos doente” ou com menores necessidades de cuidados está no final da fila.

Questão 48

Ao realizar visita domiciliar a uma família, a equipe da saúde da família (eSF) identifica atraso vacinal nas três crianças residentes na casa, todas menores de 5 anos de idade. Os pais informaram que optaram por suspender o esquema de vacinação dos seus filhos, pois questionam os benefícios de vacinas. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a eSF, nesse caso, deve

- A) acatar a decisão dos pais que possuem o pátrio poder, respeitando as convicções da família frente à questão da necessidade da imunização cada vez mais controversa.
- B) sensibilizar a família por meio de estratégias de convencimento sobre benefícios da vacinação e, em situações especiais, como em risco iminente de adoecimento, acionar o Conselho Tutelar.
- C) acionar o Conselho Tutelar de forma imediata e proceder à vacinação nessa mesma visita, uma vez que a imunização das crianças é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
- D) realizar a vacinação das crianças nessa mesma visita, contrariando a opinião dos pais, pois, do ponto de vista da proteção à criança, negar-lhes a vacinação pode ser considerado negligência.

Questão 49

Uma equipe de saúde da família tem enfrentado muitas reclamações de seus usuários — os quais são residentes de uma comunidade que fica em uma região periférica de um município de médio porte — pela dificuldade para realizar agendamento de consultas médicas e odontológicas, para colher os exames solicitados pelo médico e para conseguir os medicamentos prescritos. Isso ocorre pelas seguintes razões: a população adstrita à equipe tem mais de 4 000 pessoas cadastradas; há uma

redução do número de profissionais; e há falta de medicamentos na farmácia. Em reunião de equipe, os profissionais de saúde discutem melhor maneira de resolver essas questões.

A melhor estratégia para resolver esses problemas, com a participação da comunidade, é por meio do

A) Conselho Local de Saúde — órgão consultivo — aproximando, assim, a comunidade da unidade de saúde, e compartilhando informações sobre o funcionamento da equipe para a resolução de problemas, como o fluxo de agendamento e de coleta de exames na unidade de saúde.

B) Conselho Municipal de Saúde — órgão consultivo e permanente — com usuários, gestores e trabalhadores da saúde, a fim de avaliar a situação de saúde local, de planejar ações de organização da agenda da unidade de saúde e de fiscalizar a gestão da assistência farmacêutica.

C) Conselho Gestor de Saúde — órgão deliberativo e permanente — com profissionais de saúde e com gestores, os quais analisarão a situação da unidade de saúde e proporão alternativas de solução para a falta de profissionais, as quais serão apresentadas à comunidade.

D) Núcleo de Saúde Coletiva — órgão consultivo — a fim de ampliar as ações coletivas de forma organizada e permanente, com impacto local de suas ações, tais como a organização da demanda por meio da implantação de uma nova equipe de saúde da família após a divisão do território de abrangência.

Questão 50

Um médico de família e comunidade deseja ampliar seu campo de atuação para incluir a saúde suplementar. Ele reconhece que muitas pessoas têm planos de saúde e desejam receber atendimento médico abrangente e personalizado, em modelos assistenciais que garantam os atributos essenciais da atenção primária à saúde. No que se refere à saúde suplementar, é correto afirmar que esse médico de família poderá atuar

A) na gestão de operadoras de planos de saúde, organizando uma rede integrada e funcional, priorizando o modelo assistencial tradicional, garantindo, dessa forma, o cuidado longitudinal.

B) na atenção domiciliar, por meio de operadoras de planos de saúde, devido à impossibilidade de realizar esse tipo de atendimento de forma autônoma, garantindo a coordenação do cuidado de pacientes domiciliados, com foco na família.

C) em consultórios de estabelecimentos de saúde, prestando atendimento a clientes que estabeleceram contrato com o proprietário, em um modelo de atenção primária à saúde, com a garantia de longitudinalidade e coordenação do cuidado.

D) na assistência em clínica de operadora de plano de saúde ou em consultório particular, atuando no modelo assistencial com a coordenação de cuidados pela atenção primária à saúde, garantindo a integralidade e longitudinalidade do cuidado.

Questão 51

Em relação à humanização no âmbito do SUS, assinale a afirmativa correta.

A) Trata-se de um programa que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS.

B) Enfatiza a idealização do “homem” na construção de um sentido positivo.

C) Oferece um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas presente.

D) Constrói trocas solidárias e comprometidas com a estrita tarefa de produção de saúde.

E) São ações voltadas aos sujeitos de sua ação, ou seja, seus usuários.

Questão 52

Um jovem profissional iniciou a enriquecedora experiência da residência em saúde e, no segundo ano da formação, começou a apresentar exaustão emocional, despersonalização, baixa realização

pessoal e perda da satisfação e eficiência no atendimento aos pacientes.
Essa sintomatologia é compatível com o quadro de

- A) depressão.
- B) fadiga Industrial.
- C) síndrome de Burnout.
- D) insatisfação profissional.
- E) transtorno de ansiedade.

Questão 53

As equipes multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde (eMulti) são compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento que atuam de maneira complementar e integrada com as equipes da Atenção Primária à Saúde – APS e da Rede de Atenção à Saúde - RAS.

As opções a seguir apresentam ações desenvolvidas, prioritariamente, pela eMulti, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- A) O atendimento individual, em grupo e domiciliar.
- B) A oferta de ações de saúde à distância.
- C) O matriciamento e intervenções no território.
- D) As atividades coletivas e a construção de projetos terapêuticos.
- E) O desenvolvimento de práticas setoriais.

Questão 54

A população em situação de rua é um fenômeno mundial, com características diferentes em cada país. No Brasil, o cuidado com essa parcela da população obteve importante conquista com a definição da Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPR), que levou ao surgimento de novos serviços e equipamentos para o atendimento dessa população: o Consultório de Rua e o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).

Sobre o Consultório na Rua (eCR), analise as afirmativas a seguir.

- I. As eCR são multiprofissionais e lidam com os diferentes problemas e necessidades de saúde da população em situação de rua.
- II. As eCR desempenharão suas atividades in loco, de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde (UBS).
- III. As atividades das eCR incluirão a busca ativa e o cuidado aos usuários de álcool, crack e outras drogas.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 55

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) era, inicialmente, denominado Projeto Terapêutico Individual. No entanto, o termo *singular* representa melhor o seu objetivo, pois destaca que o projeto pode ser feito para grupos ou famílias e não somente para indivíduos. Na construção do PTS, podemos ressaltar quatro momentos importantes: definição de hipóteses diagnósticas; definição das metas; divisão de responsabilidades; avaliação e reavaliação. Considerando a construção de um Projeto

Terapêutico Singular (PTS) singular, assinale a afirmativa correta.

- A) As ações devem ser desenvolvidas desconsiderando as necessidades e as possibilidades de cada usuário, de forma que ultrapassem a estrutura física dos serviços de saúde.
- B) O objetivo é traçar a estratégia de intervenção, considerando as necessidades do usuário, os recursos disponíveis pela equipe e o território a que pertence sua família.
- C) A articulação dos serviços com o oferecimento de suporte social aos pacientes não contribui para o restabelecimento de vínculos fragilizados ao longo do processo de adoecimento.
- D) A equipe deve reproduzir uma experiência bem-sucedida de um outro usuário para padronizar o tratamento, objetivando garantir resultados consistentes em todos os pacientes.
- E) O foco da construção deve ser o usuário em sua singularidade e esse processo deve contemplar a expectativa dos profissionais que atuam no caso sobre o que deve ou não ser tratado a partir do ponto de vista de cada um.

Questão 56

Leia o fragmento a seguir.

Ao abrigo e para os efeitos previstos na Lei nº 25/2012, o presente documento traduz desde já o meu desejo consciente, livre e esclarecido, no que concerne aos cuidados de saúde que pretendo receber, ou que não pretendo receber, no caso de, por qualquer razão, me encontrar incapaz de expressar a minha vontade pessoal e autonomamente. Este documento, que subscrevo sendo maior de idade e capaz e não me encontrando interdito ou inabilitado por anomalia psíquica, é por mim unilateral e livremente revogável a qualquer momento. Utilizado pelo paciente em conjunto com a equipe multidisciplinar, em cuidados paliativos, dá-se a este documento o nome de

- A) testamento familiar.
- B) consentimento assistido.
- C) orientações *post-mortem*.
- D) diretivas antecipadas de vontade.
- E) Lei de diretrizes e base em saúde.

Questão 57

Matriciamento ou apoio matricial é um modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, em um processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção-terapêutica. Dessa forma, apoio matricial e equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, objetivando ampliar as possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões.

Assinale a opção que apresenta os instrumentos do processo de matriciamento.

- A) Atendimento, visita domiciliar e intervenções conjuntas entre profissionais de saúde dentro de suas especialidades para garantir a área de saber em profundidade.
- B) Protocolos unidisciplinares, atendimentos centralizados nos núcleos específicos de cada especialidade e interconsulta.
- C) Interconsulta, encaminhamento entre especialistas e centros de regulação para agilizar o agendamento da consulta.
- D) Atendimentos e intervenções conjuntas, visita domiciliar conjunta, escala de complexidade para qualificar os encaminhamentos entre os diferentes níveis de atenção.
- E) Interconsulta, atendimentos e intervenções conjuntas, visita domiciliar conjunta e contato à distância com o uso do telefone e de outras tecnologias de comunicação.

Questão 58

A Reforma Psiquiátrica é considerada um processo histórico de formulação crítica e prática que tem como objetivos e estratégias o questionamento e a elaboração de propostas de transformação do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria, ao propor um novo lugar social para a loucura e uma clínica ampliada. Em relação à *clínica ampliada*, assinale a afirmativa correta.

- A) Empenha-se em propor atenção na melhoria dos sintomas, transformando os usuários em objetos de intervenções, já que eles não possuem conhecimento técnicos para pensar o cuidado.
- B) Empenha-se em propor atenção a partir das questões de vida do sujeito, com a intenção de enfatizar uma abordagem sintomatológica da doença, em contraposição às práticas homogeneizantes.
- C) Empenha-se em propor atenção na perspectiva da produção de saúde, buscando o isolamento social para uma resposta mais efetiva do cuidado em ambiente hospitalar ou ambulatorial especializado.
- D) Empenha-se em propor atenção e conduta singularizadas, com o objetivo de resgatar a subjetividade do usuário, considerando sua autonomia e o contexto social em que ele está inserido.
- E) Empenha-se em propor atenção e estratégias de inclusão social dos sujeitos, buscando o seu foco na iniciativa organizativa do novo modelo assistencial na perspectiva da atenção psicossocial.

Questão 59

Rafael, 19 anos, nos últimos dois meses, após rompimento com a namorada, passou a ficar a maior parte do tempo dentro de um quatinho no fundo do terreno, saindo apenas para fazer as refeições. No CAPS, o jovem fala que está bem e que não tem saído pois está “trabalhando em casa”, mas não diz que trabalho seria esse, apenas que é “confidencial”. Nos atendimentos com sua referência, se restringe a falar sobre seu sono. É visto com frequência conversando com a copeira do CAPS e, numa dessas conversas, após o oferecimento do almoço, Rafael se recusou a comer e afirmou que só come alimentos na cor vermelha. Ele ficou nervoso e começou a exigir esses alimentos de forma contundente, alegando que eles ajudam a “purificar seu sangue”. Diante dessa situação, sobre o *acolhimento no CAPS*, assinale a afirmativa correta.

- A) O CAPS, após avaliar a situação, deve encaminhá-lo diretamente a um hospital de emergência, onde há profissionais mais capacitados para lidar com essas situações.
- B) O CAPS, devido à convivência com o usuário que costuma ter frequência diária na instituição, deve orientá-lo para o técnico de referência, em função do vínculo existente entre eles, e, na ausência deste, o paciente deve aguardar para ser acolhido quando o técnico estiver presente.
- C) A responsabilidade de lidar com as situações de crise reforça a responsabilidade do CAPS em dar suporte à crise, buscando sua significação temporal e singular para o sujeito.
- D) Apesar de sua responsabilidade territorial, os CAPS não são serviços de emergência e, portanto, não devem atender situações de crise.
- E) O acolhimento da crise deve ser reduzido ao que podemos chamar de agudização da sintomatologia psiquiátrica em que o sujeito não está em sofrimento.

Questão 60

É importante reconhecer que os transtornos mentais infantis e juvenis causam sofrimentos, prejuízos na sociabilidade e limitações no desenvolvimento. Eles podem persistir na vida adulta, mas são potencialmente tratáveis. Acerca das orientações para a clínica infantil e juvenil no contexto da reforma psiquiátrica e do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a afirmativa correta.

- A) Todo o cuidado dedicado às crianças e aos adolescentes está submetido a adaptação implacável a um padrão predefinido de normalidade.

- B)** A escuta da criança é priorizada ao longo do acompanhamento em detrimento da escuta de seus familiares ou responsáveis, no intuito de preservar a confiança na relação terapêutica.
- C)** A elaboração de uma hipótese diagnóstica não deve tomar o lugar do respeito à singularidade, que deve ser sempre articulado ao diagnóstico situacional.
- D)** Os conflitos quanto às questões de gênero, trabalho, educação e família devem ser desconsiderados, se quisermos falar da saúde mental na adolescência.
- E)** A intervenção tecnicista se faz necessária em crianças pequenas, pois trata-se de um objeto a ser moldado para o futuro.



SIMULADO 02

Enamed 2026



Acadêmico (a): _____

Fase: _____

Gabarito

Questão 01	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 31	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 02	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 32	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 03	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 33	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 04	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 34	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 05	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 35	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 06	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 36	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 07	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 37	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 08	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 38	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 09	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 39	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 10	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 40	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 11	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 41	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 12	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 42	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 13	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 43	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 14	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 44	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 15	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 45	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 16	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 46	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 17	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 47	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 18	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 48	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 19	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 49	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 20	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 50	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 21	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 51	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 22	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 52	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 23	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 53	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 24	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 54	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 25	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 55	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 26	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 56	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 27	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 57	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 28	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 58	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 29	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 59	(A) (B) (C) (D) (E)
Questão 30	(A) (B) (C) (D) (E)		Questão 60	(A) (B) (C) (D) (E)